

METÁSTASIS CEREBRALES

Ana E. Gómez-Caminero Gómez

INTRODUCCIÓN

Las metástasis cerebrales presentan una elevada incidencia, con sintomatología y pronóstico adverso. Son diez veces más frecuentes que las neoplasias primarias del SNC y son la principal causa de hipertensión intracraneal en el paciente con cáncer. En los adultos, el primario más frecuente es pulmón (40%) y en los jóvenes, los sarcomas y tumores germinales. La localización es normalmente por diseminación hematógena: A la superficie (leptomeninges, meninges) o al parénquima cerebral (cerebro 80%, cerebelo 15% y tronco 5%).

DIAGNÓSTICO

Ante cualquier paciente oncológico con sintomatología neurológica debemos descartar la presencia de metástasis cerebrales. La sintomatología se desarrollara progresivamente en días o semanas; ocasionalmente puede ocurrir una hemorragia intrametastásica que provoca una rápida progresión de los síntomas neurológicos.

Los mecanismos por los que se suele ocasionar hipertensión intracraneal son el edema perilesional, compresión de estructuras cerebrales por crecimiento tumoral, hemorragia cerebral e hidrocefalia obstructiva. En relación a estos mecanismos los síntomas que se presenten, pueden estar en relación tanto con el efecto masa y el aumento de presión intracraneal (cefalea, náuseas, vómitos, deterioro cognitivo) o en relación con la afectación focal de zonas cerebrales específicas (Alteraciones motoras y/o sensitivas, crisis comiciales, trastornos del habla)

Ante la sospecha de metástasis cerebrales ha de realizarse un TC o RMN con contraste. Aunque el TC suele ser suficiente en la mayoría de los casos, la RMN es más sensible y se considera la prueba diagnóstica de elección. Si existe evidencia radiológica de metástasis cerebrales sin tumor primario conocido, debe realizarse una Rx de tórax, ya que en un 60% de casos mostrará una masa pulmonar; continuándose con el estudio de extensión, siendo esencial la mamografía en las mujeres.

El diagnóstico diferencial ha de realizarse con: primario cerebral, lesiones inflamatorias, abscesos, infartos cerebrales, hemorragia.

TRATAMIENTO DE URGENCIAS

- **Medidas iniciales: dexametasona IV** bolo 10-16 mg seguidos de 4-6 mg cada 6-8 horas al menos durante 72 horas, con pauta descendente posterior, disminuyendo un cuarto de dosis cada cinco días. Si reaparecieran los síntomas neurológicos se volvería a la pauta con la que se controlaba. La reducción de dosis se llevará a cabo a partir de la segunda semana de tratamiento. Si continua el empeoramiento clínico, algunos autores recomiendan asociar Manitol IV.
- **Radioterapia:** los efectos agudos de la radioterapia son la alopecia, cefalea, fatiga, eritema, náuseas y vómitos, somnolencia, que suelen revertir rápidamente tras el tratamiento. Se consigue paliar la sintomatología neurológica en el 75-85% de los casos, disminuyendo la muerte por causas neurológicas.
- **Neurocirugía** está indicada en:
 - Sospecha mediante TC o RMN de lesiones benignas

- Ante la necesidad de diagnóstico histológico
- Cuando no existe primario conocido,
- Empeoramiento clínico que requiera descompresión quirúrgica,
- Ante metástasis técnicamente extirpables con primario controlado.

BIBLIOGRAFÍA

- “Guía Práctica de actuación en Urgencias Oncológicas para Especialistas Internos Residentes y Médicos de Atención Primarias”. Hospital Juan Ramón Jiménez – Huelva
- “Manual para el tratamiento de Urgencias Oncológicas”. Hospital Donostia